КЛИНИЧЕСКИЙ КОМПАС

Первичная анкета пациента — полное функциональное и визуальное ТЗ

Для разработчика · демоверсия · 21 октября 2026

Суть: первичная анкета — не единый длинный тест, а библиотека тематических карточек. Пациент может не помнить диагноз; система помогает найти понятное описание, но сохраняет неопределённость. Заболевание, препарат, визит и файл связаны между собой. Врач видит краткое резюме и исходные записи.

- Полный исходный текст анкеты включён в приложение без смыслового сокращения.
- Дополнительная часть переведена в спецификации полей, ветвлений, экранов, цветов и прав доступа.
- Визуальные макеты — иллюстрации, а не готовые Figma-компоненты; тексты и числовые данные на них демонстрационные.

СОДЕРЖАНИЕ

01. Карта экранов, роли, цвета и типы данных
02. Категории анкеты: точные вопросы и поля
03. Соматические заболевания по системам органов
04. Связи между заболеваниями, лекарствами, визитами и файлами
05. Две версии интерфейса и сводка специалиста
06. Безопасность, приватность и MVP
07. Примеры сгенерированных экранов
08. Полный исходный текст анкеты (приложение)

1. Сценарий и структура продукта

Анкета предназначена для самостоятельного предварительного сбора анамнеза перед консультацией. Она не ставит диагноз и не заменяет клиническую оценку. Пользователь видит последовательность «Окно доверия → выбор главных целей → карточки категорий → релевантные уточнения → проверка заполненного → отправка специалисту».

Состояние	Поведение интерфейса	Что сохраняется
Не начинал	Показывает карточки, ориентировочное время, приватность	Только согласия и настройки
Заполняет	Автосохранение после ответа; можно вернуться	Черновик, timestamp, версия вопросов
Пропустил	«Не знаю», «Не помню», «Обсудить лично», «Пропустить» — разные статусы	Не записывать 0/«нет» вместо пропуска
Отправил	Краткий итог и статусы передачи	Версия анкеты и время отправки
Врач просмотрел	Проверка фактов, открытие оригинала файла	Подтверждающие пометки врача

1.1. Текст «Окна доверия»

> «Иногда сложно сразу вспомнить названия заболеваний или объяснить, что именно беспокоит. Здесь можно описать всё своими словами. Вы можете пропускать необязательные вопросы и возвращаться к ним позже. Ответы помогут специалисту подготовиться к консультации. До начала заполнения мы объясним, кто увидит сведения, как долго они хранятся и что происходит при сообщении об опасных симптомах».

Кнопки: «Начать», «Кто увидит мои ответы?», «Можно ли пропускать?». Не обещать абсолютную конфиденциальность, круглосуточный просмотр врачом или мгновенную помощь.

1.2. Компоненты одной категории

Слой	Визуально	Поведение
Категория	Карточка с пастельным фоном, значком, названием и коротким пояснением	Раскрывается без перехода к длинному списку
Подкатегория	Аккордеон; подпункты по смыслу	Поиск по термину и бытовому синониму
Вопрос	Заголовок, микрообъяснение «зачем спрашиваем»	Обязательность только после клинической настройки
Ответ	чек-лист / радио / число / дата / шкала	Отдельно unknown, skip, decline
Уточнение	Появляется внизу выбранного пункта	Не навязывать новую длинную анкету
Вложение	Файл, голос, текст; «обсудить со специалистом»	Отдельный статус и контроль доступа

2. Цветовая система и визуальная организация

Цвет помогает ориентироваться в категориях, но **не обозначает тяжесть заболевания, риск или оценку пациента**. Клинические предупреждения имеют отдельные иконку и подпись. Точные HEX-коды для светлого фона и акцента приведены ниже.

Категория	Фон / акцент (HEX)	Назначение
Обо мне и антропометрия	#EAF2FF · #3175D8	Данные, рост, масса, дата измерений
Причина обращения	#FDE8F0 · #DB467D	Жалобы по тематическим группам
Психическое состояние	#F0E9FF · #7356CC	Эмоции, тревога, внимание и др.
Соматический анамнез	#E4F7F0 · #15866C	Заболевания и жалобы по системам
Лекарства и аллергии	#FFF0E1 · #C66A1B	Схемы, фактический приём, реакции
Анализы и документы	#E9F0FF · #4369CA	Результаты, выписки, изображения
Посещения специалистов	#EAF3FC · #3F73AF	История обращений и лечения
Моя семья и поддержка	#E9F8EE · #288657	Социальный контекст
История здоровья семьи	#E8F5ED · #3B906B	Родственники и подсказки
Учёба и работа	#EAF2FF · #3979C1	Нагрузка, функционирование
Интересы и увлечения	#FFF4DF · #B67B28	Ресурсы, изменение интереса
Повседневная жизнь	#FFF4E4 · #B2783D	Сон, питание, активность, привычки
Менструальный цикл	#FDE7F2 · #CA548D	По желанию и по показаниям
История жизни и стресс	#F1ECFF · #7760AE	События, деликатные вопросы
Цели и предпочтения	#E5F7F3 · #2F8B79	Ожидания и совместное планирование

Правило дизайна: карточка категории — скругление 12–16 px, светлый фон, темный текст; активное состояние — акцентная обводка 2 px. Один тип поля выглядит одинаково во всех категориях. У врача использовать преимущественно нейтральную палитру, без котов и без геймификации. У пациента котики допустимы только в мягких подсказках/прогрессе, не в предупреждениях.

2.1. Общая карта сгруппированных разделов

Крупный блок	Вложенные категории
Я и причина обращения	Обо мне; рост/масса; основные жалобы; предпочтения
Психическое и телесное здоровье	Эмоции, тревога, сон; заболевания и симптомы по системам; менструальный цикл по показаниям
История лечения	Лекарства, витамины, аллергии; обращения к специалистам; анализы и файлы
Социальная и семейная история	С кем живу; семейная родословная; учёба/работа; хобби; привычки; история жизни
Мои цели	Ожидания, важные вопросы, материалы для консультации

3. Поля и сценарии для каждой категории

Ниже — спецификации отдельных модулей. Для каждого указаны: внешний вид, текст вопросов, структура данных, условные переходы и формат отображения в кабинете специалиста. Длинные списки вариантов можно раскрывать по требованию, а не показывать весь набор одновременно.

01 · Обо мне и антропометрия

Как выглядит. Карточка «Обо мне» — светло-голубой фон; внутри две вкладки: «Основные данные» и «Измерения». Справа от роста/массы — контурный нейтральный силуэт человека. Никакого обязательного изображения тела пациента.

Текст для пациента / вопросы:

- «Как к вам обращаться?»
- «Когда вы родились?»
- «Какой у вас рост и масса тела (если знаете)?»
- «Изменялась ли масса тела в последнее время?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Дата рождения	date	Возраст: автоматически из даты, с учётом даты консультации
Рост	decimal, см	Измерен/примерно; дата
Масса	decimal, кг	Измерена/примерно; дата
ИМТ	computed	масса (кг) / [рост (м)]²; только если допустимо
Динамика массы	single choice + period	Увеличилась/уменьшилась/не изменилась/не знаю

Условные переходы. Если возраст несовершеннолетний, беременность, состояние с риском РПП или иная причина ограничения — не применять взрослые пороги ИМТ автоматически; отключить оценочную подсветку.

Что видит врач. Рост, масса, дата и источник; ИМТ как расчётный показатель и его применимость; не подтверждённые сведения помечены.

02 · Причина обращения

Как выглядит. Первый экран — вопрос «Что вас сейчас беспокоит?» и раскрывающийся каталог из 9 групп: настроение, тревога, сон/энергия, мысли/внимание, физическое, отношения, учёба/работа, поведение, другое.

Текст для пациента / вопросы:

- «Что вас сейчас беспокоит?»
- «Когда это началось?»
- «Как часто проявляется?»
- «Насколько мешает вашей жизни?»
- «Что помогает или ухудшает состояние?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Группа жалобы	multi select	Можно выбрать несколько
Конкретная жалоба	multi select	Разговорные формулировки из исходной анкеты
Начало	date/approximate	Точная или приблизительная дата
Частота	select/count	Эпизоды либо категории
Влияние	integer 0–10	Пояснения у концов шкалы
Приоритет	checkbox	Хочу обсудить на приёме

Условные переходы. Появление релевантных уточнений только для выбранных жалоб; выбор «другое» открывает текст. Угрожающие симптомы требуют отдельного заранее утверждённого протокола.

Что видит врач. Топ-3 причины обращения, начало/длительность, выраженность, влияние на функционирование, комментарии и срочные сигналы отдельно.

03 · Психическое состояние

Как выглядит. Сиреневая карточка со сгруппированными пунктами «Настроение», «Тревога», «Мысли и внимание», «История психиатрической помощи». Это описание самооценки, а не постановка диагноза.

Текст для пациента / вопросы:

- «Как вы оцениваете своё настроение за последние две недели?»
- «Были ли периоды выраженной тревоги или паники?»
- «Как изменились внимание, память и энергия?»
- «Обращались ли раньше за психиатрической/психологической помощью?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Настроение	integer 0–10	Период «последние 2 недели», фиксированное направление
Тревога	integer 0–10	Рядом контекст «сегодня» или «2 недели»
Симптомы	multi select	Разговорные названия
Предыдущее лечение	linked visit/medication	События, курсы, эффект и переносимость
Госпитализация	yes/no/unknown	Дата/причина по желанию

Условные переходы. При прошлой помощи — уточнить специалиста, диагноз со слов, лечение и документы; при чувствительных вопросах допустить «обсудить лично». Суицидальный риск идёт по независимому протоколу.

Что видит врач. Самоописание, предыдущие обращения, курсы терапии, длительность, а также непройденные/отложенные вопросы без ложных выводов.

04 · Моё здоровье

Как выглядит. Мятный главный экран «Моё здоровье» — карточки систем органов, внутри поиск по диагнозам и разговорным подсказкам. На уровне системы отдельно «Заболевания» и «Симптомы».

Текст для пациента / вопросы:

- «Говорили ли вам врачи о заболеваниях?»
- «Помните ли, с какой системой организма это связано?»
- «Назначали ли препараты или исследования?»
- «Есть ли заключения или результаты?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Система органов	single/multi select	Ниже — подробный каталог систем
Название диагноза	text + search	Поле допускает «не помню»
Источник	enum	со слов / документ / подтверждено врачом
Период	approximate date	Когда примерно
Текущее состояние	enum	сейчас / раньше / неизвестно
Связанные объекты	ids	Лекарство, визит, анализ, файл

Условные переходы. При выборе «не знаю диагноз» предложить фразы «щитовидка», «проблемы с сахаром», «низкий гемоглобин»; подсказки не должны подтверждать диагноз. К одной записи можно добавить 0..N лекарств, визитов и файлов.

Что видит врач. Группировка по системе; разделять «со слов пациента» и «подтверждено документом/врачом». Врач открывает связанные события из одной строки.

05 · Лекарства, витамины, аллергии

Как выглядит. Персиковый раздел. Отдельные блоки «Назначено», «Фактически принимаю», «Принимал(а) ранее», «Без рецепта и добавки», «Аллергии/реакции».

Текст для пациента / вопросы:

- «Какие препараты вы принимаете сейчас?»
- «Как часто и в какое время вы их принимаете?»
- «Кто назначил?»
- «Были ли реакции или трудности с приёмом?»
- «Не помните название — можете сфотографировать упаковку?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Препарат	search/text	Торговое название и МНН при проверке
Форма и дозировка	select + number + unit	табл., мг, мкг, мл и др.

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Назначенная схема	structured	Источник назначения
Фактический приём	enum	как назначено / иначе / нерегулярно / неизвестно
Даты	date/approx	Начало/прекращение
Нежелательная реакция	linked symptom	Время, выраженность, статус
Связь с заболеванием	id optional	Не выводить диагноз из препарата

Условные переходы. Добавление заболевания открывает необязательное предложение «Связать с лекарством». При вводе лекарства не определять заболевание автоматически. Пропуск в дневнике не равен пропуску дозы.

Что видит врач. Проверенная схема рядом с самоотчётом; лекарства без рецепта, витамины, БАДы отдельно; аллергия ≠ иной побочный эффект.

06 · Обследования и документы

Как выглядит. Голубой файловый каталог. Слева фильтры «Общие», «Биохимия», «Гормоны», «Железо/витамины», «ЭКГ», «Нейро», «УЗИ/КТ/МРТ», «Выписки», «Другое»; справа предпросмотр.

Текст для пациента / вопросы:

- «Есть результаты анализов или обследований?»
- «Когда проводилось обследование?»
- «С каким вопросом оно связано?»
- «Хотите добавить комментарий для специалиста?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Файл	upload	PDF/JPG/PNG; лимиты конфигурируются
Название/тип	text/select	Пациент может не знать
Дата обследования	date/approximate	Не путать с датой загрузки
Источник	text	Лаборатория/учреждение необязательно
Связь	entity ids	Заболевание, визит, жалоба
Статус	enum	не просмотрено / проверяется / подтверждено / нечитабельно

Условные переходы. Можно прикрепить сразу несколько файлов; фото интимных областей требуют отдельного согласия и защищённого доступа. Извлечённые OCR/ИИ цифры нельзя автоматически считать достоверными.

Что видит врач. Файлы списком, миниатюра, дата, тип, комментарий, связь с событием, статус проверки, открытие оригинала.

07 · Посещения специалистов

Как выглядит. Голубая временная лента с карточками специальностей. Доступен поиск врача по специальности и список. Для психолога указывать роль отдельно от врача.

Текст для пациента / вопросы:

- «Были ли вы у других специалистов?»
- «К какому специалисту и примерно когда?»
- «Что рекомендовали?»
- «Продолжаете ли наблюдаться?»
- «Есть ли заключение?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Тип специалиста	search	Эндокринолог, кардиолог, психиатр, психолог...
Дата	date/approx	не помню допустимо
Причина	text/multi	жалоба или заболевание
Исход визита	multi	диагноз / лечение / обследование / наблюдение
Статус наблюдения	enum	продолжаю / завершено / неизвестно
Связи	ids	препарат, обследование, файл

Условные переходы. При психиатрической или психотерапевтической помощи дополнительно запросить прошлые подходы, переносимость, причину прекращения, что пациент не хотел бы повторять.

Что видит врач. Хронология визитов, активное наблюдение, ожидающие уточнения сведения и связанные назначения.

08 · Моя семья и социальная поддержка

Как выглядит. Мягкая зелёная карточка: «С кем живу», «Близкие и поддержка», «Обязанности по уходу». Сведения о взаимоотношениях отделены от генетической родословной.

Текст для пациента / вопросы:

- «С кем вы сейчас живёте?»
- «Есть ли человек, на которого можно положиться?»
- «Заботитесь ли вы о ком-то?»
- «Есть ли что-то в отношениях, что важно обсудить?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Состав домохозяйства	single/multi	семья, друзья, один/одна, общежитие
Поддержка	yes/no/unsure	с кем комфортно обратиться
Нагрузка по уходу	multi/text	если есть
Отношения	select/text	по желанию

Условные переходы. Если пациент не хочет раскрывать контакты близких — не требовать имён, телефонов и сведений третьих лиц.

Что видит врач. Контекст поддержки и нагрузки; чувствительные заметки только при необходимом доступе.

09 · История здоровья семьи

Как выглядит. Зелёная интерактивная родословная: выбор родства → система органов → известный диагноз или подсказка → комментарий. Для демо допустим упрощённый список родственников.

Текст для пациента / вопросы:

- «Есть ли у близких родственников заболевания, о которых вы знаете?»
- «У кого именно?»
- «Помните название или только описание?»
- «Примерно в каком возрасте началось?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Родство	select	мать/отец/сиблинги/дедушки и др.
Заболевание	search/free text	разговорные подсказки
Возраст начала	number/approx	если известен
Источник	enum	со слов/документ
Уверенность	enum	точно / не уверен / не знаю
Комментарий	text/audio	необязательно

Условные переходы. Сведения о третьих лицах собирать минимально; не переносить семейную историю в подтверждённые диагнозы пациента.

Что видит врач. Родословная/список с источником и неопределённостью, без автоматического расчёта индивидуального риска.

10 · Учёба и работа

Как выглядит. Голубой экран с выбором «Учусь», «Работаю», «Совмещаю», «Не работаю сейчас», «Другое». Затем раскрываются только подходящие ветки.

Текст для пациента / вопросы:

- «Чем вы сейчас занимаетесь?»
- «Как проходит обычный учебный или рабочий день?»
- «Мешает ли состояние занятиям?»
- «Что сейчас наиболее трудно?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Занятость	enum	учёба/работа/оба/другое
Специальность	text optional	можно не указывать работодателя
График	enum	дневной/сменный/ночной

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Нагрузка	integer 0–10	субъективная
Влияние здоровья	integer 0–10	с фиксированными якорями
Пропуски	count or categories	уточнение только при необходимости

Условные переходы. Для учёбы: учебное заведение/курс/расписание — по желанию. Для работы: профессия/график/стрессоры; адрес работодателя не обязателен.

Что видит врач. Статус занятости, тип графика, затруднения, ресурсы; короткий результат для сводки.

11 · Интересы и ресурсы

Как выглядит. Тёплая жёлтая карточка с плитками: спорт, книги, музыка, фильмы, игры, творчество, природа, языки, друзья, волонтёрство, другое.

Текст для пациента / вопросы:

- «Чем вам нравится заниматься?»
- «Изменился ли интерес к этому в последнее время?»
- «Есть ли занятие, к которому хотите вернуться?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Хобби	multi select	можно добавить своё
Интерес	enum	сохранился / снизился / вырос / не знаю
Любимый ресурс	text	по желанию
Цель возвращения	linked goal	если пациент сам выбрал

Условные переходы. При потере интереса предложить короткий вопрос о длительности, но не объявлять это автоматически ангедонией.

Что видит врач. Значимые занятия, изменения интереса, потенциальные персональные цели.

12 · Повседневная жизнь

Как выглядит. Бежевая/жёлтая категория: вкладки «Сон», «Питание», «Движение», «Привычки», «Самостоятельность». Подсчёт калорий скрыт по умолчанию.

Текст для пациента / вопросы:

- «Как обычно проходит ваша ночь?»
- «Менялся ли аппетит?»
- «Бывает ли, что эмоции влияют на желание поесть?»
- «Какова ваша обычная активность?»
- «Есть ли привычки, которые важно учитывать?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Сон	time + rating	ч/мин, проблемы, качество
Аппетит	scale 0–10 or category	снижен/обычный/повышен

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Регулярность еды	count/yes-no	без стигматизации
Стресс и еда	enum	больше/меньше/без изменений
Активность	minutes/enum	частота/вид
Кофеин/алкоголь/никотин	frequency	по желанию и показаниям

Условные переходы. При риске РПП возможно полностью убрать детальный пищевой и весовой контроль. Нельзя вычислять дефициты нутриентов по одному воспоминанию об обеде.

Что видит врач. Режим и наблюдаемые трудности, без моральных оценок поведения.

13 · Менструальный и репродуктивный анамнез

Как выглядит. Нежно-розовый необязательный раздел, предлагаемый по релевантности и без предположений о гендерной идентичности. Отдельные настройки приватности.

Текст для пациента / вопросы:

- «Есть ли у вас менструации?»
- «Когда начались последние?»
- «Обычно цикл регулярный?»
- «Бывают ли боли, изменения настроения, необычные выделения?»
- «Есть ли беременность/лактация либо вероятность беременности, значимая для лечения?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Наличие менструаций	enum	да/нет/затрудняюсь/не хочу указывать
Первый день последних	date	если известно
Длина цикла	days/approx	если известна
Регулярность	enum	регулярный/нерегулярный/не знаю
Боль	integer 0–10	по желанию
Выделения	select/text	особенности, время, фото только при согласии
Беременность/лактация	sensitive enum	только клинически обоснованный вопрос

Условные переходы. Не определять фазу цикла автоматически как достоверную; на основании одной даты нельзя судить о беременности или патологии. При опасных симптомах — отдельный протокол.

Что видит врач. Данные, релевантные лечению, отдельно от общего сводного экрана с разграничением доступа.

14 · История жизни

Как выглядит. Спокойная сиреневая карточка; деликатные формулировки, много опций «обсудить лично», «пока не готов(а)» и без требования пересказывать травму.

Текст для пациента / вопросы:

- «Были ли значимые изменения в последнее время?»
- «Хотите что-то рассказать о событиях, повлиявших на вас?»
- «Вам удобнее написать или обсудить лично?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Событие	multi select	переезд/утрата/отношения/болезнь/другое
Время	date/approx	необязательно
Влияние	scale 0–10	по желанию
Режим раскрытия	enum	текст / личная беседа / пропуск

Условные переходы. При желании пациента лично обсудить тему — закончить ветку, оставить маркер для специалиста. Не включать чувствительные подробности в пуши.

Что видит врач. Только выбранные значимые события и отметки «обсудить», без автоматической травматологической интерпретации.

15 · Цели и предпочтения

Как выглядит. Мятная карточка — 1–3 основных приоритета, вопросы о том, чего пациент хочет от помощи, и о нежелательных последствиях терапии.

Текст для пациента / вопросы:

- «Что было бы полезным результатом помощи?»
- «Какие три изменения наиболее важны?»
- «Есть ли в лечении что-то, чего вы хотели бы избежать?»

Поле	Тип данных	Подпись / уточнение
Цель	text/select	до 3 в краткой версии
Приоритет	ordinal	1–3
Исходная оценка	integer 0–10	только если согласовано
Предпочтения	multi select	сонливость, масса, функционирование и др.
Комментарий	text/audio	почему это важно

Условные переходы. Цель пациента обсуждается и конкретизируется со специалистом, не превращается в автоматический прогноз лечения.

Что видит врач. Главные цели, субъективные критерии успеха и предпочтения перед лечением.

4. Соматические жалобы и заболевания: подкатегории по системам

В отличие от сплошного перечня, пациент открывает систему органов и выбирает **отдельный симптом** или заболевание. Например: «ЖКТ → Тошнота → С какого дня? → Насколько сильно? → Как часто? → Мешает ли есть? → Добавить голос/файл». Наличие симптома не подтверждает его лекарственную причину.

Система · ЖКТ

Что можно выбрать: Тошнота, рвота, диарея, запор, изжога, боль в животе, аппетит

Подсказка: Вопрос: «Бывали ли проблемы с желудком или кишечником?»; подсказки «язва», «гастрит», «изжога».

Поля: симптом → частота/длительность/0–10; заболевания отдельной карточкой; свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

Система · Эндокринная

Что можно выбрать: Щитовидная железа, диабет, гормональные нарушения, изменения массы

Подсказка: «Говорили о щитовидке или сахаре?», «Назначали L-тироксин, инсулин или другие средства?»

Поля: со слов/документ; препараты; ТТГ, глюкоза как связанные файлы; свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

Система · Сердце и сосуды

Что можно выбрать: Гипертензия, аритмия, сердцебиение, отёки, обмороки

Подсказка: «Повышалось ли давление?», «Говорили, что нарушен ритм?»

Поля: АД мм рт. ст., ЧСС уд/мин, симптомы и даты; свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

Система · Дыхательная

Что можно выбрать: Астма, бронхиты, одышка, кашель, аллергии

Подсказка: «Нуждались ли в ингаляторе?», «Бывает тяжело дышать?»

Поля: приступы, длительность, ингаляторы, документы; свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

Система · Нервная

Что можно выбрать: Мигрень, судороги, головокружение, нарушения чувствительности

Подсказка: «Бывали сильные головные боли?», «Наблюдались у невролога?»

Поля: частота, локализация, 0–10, ЭЭГ/МРТ если есть; свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

Система · Почки и мочеполовая

Что можно выбрать: Камни, инфекции, нарушения мочеиспускания

Подсказка: «Были проблемы с почками или мочеиспусканием?»

Поля: симптом/период, анализы, консультации; свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

Система · Кровь

Что можно выбрать: Анемия, кровотечения, нарушения свёртывания

Подсказка: «Говорили про низкий гемоглобин или железо?»

Поля: ОАК/ферритин с единицами и датами (после проверки); свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

Система · Иммунная и ревматологическая

Что можно выбрать: Аутоиммунные заболевания, воспаление суставов

Подсказка: «Говорили об аутоиммунном заболевании?», «Болят/опухают суставы?»

Поля: наличие, история лечения, ревматолог; свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

Система · Кости и мышцы

Что можно выбрать: Боль спины, суставов, травмы, операции

Подсказка: «Были травмы, операции, хроническая боль?»

Поля: локализация, 0–10, даты, влияние на дела; свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

Система · Кожа

Что можно выбрать: Сыпь, зуд, экзема, псориаз

Подсказка: «Бывают высыпания, кожные реакции?»

Поля: начало, локализация, снимок при согласии; свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

Система · Репродуктивная

Что можно выбрать: Менструальные симптомы, урологические/гинекологические состояния

Подсказка: «Есть ли вопросы по циклу или репродуктивному здоровью?»

Поля: деликатная категория, дата/симптом, приватность; свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

Система · Инфекционные

Что можно выбрать: Значимые инфекции, длительные последствия

Подсказка: «Была серьёзная инфекция или госпитализация?»

Поля: примерный период, лечение, выписка; свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

Система · Онкологические

Что можно выбрать: Новообразования, лечение, наблюдение

Подсказка: «Говорили об опухоли или новообразовании?»

Поля: подтверждение только документом/врачом; свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

Система · Психические заболевания в прошлом

Что можно выбрать: Диагнозы, психотерапия, госпитализации

Подсказка: «Получали ли ранее психиатрическую помощь?»

Поля: история, лекарства, исход без самостоятельной диагностики; свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

Система · Другое и не знаю

Что можно выбрать: Не могу определить систему или название

Подсказка: «Можете описать своими словами?»

Поля: свободная запись, голос, фото документа, статус неизвестно; свободный текст/голос/файл; «Не знаю»; «Хочу обсудить»

4.1. Универсальная карточка симптома

Поле	Как вводится	Показывать при
Название и система	Поиск / чек-лист / свой вариант	Всегда
Когда началось	Дата или «примерно»	Если симптом выбран
Как часто	Количество или частота словами	Если применимо
Выраженность	0–10 с понятными якорями, при необходимости 0–4	При клинической релевантности
Где ощущается	Схема тела / текст	При болях/сыпях
Было до лекарства?	Да / нет / не знаю	Если связан с лечением
С чем может быть связано?	Свободное предположение пациента	Необязательно
Комментарии	Текст + голос + документы	Всегда по желанию

5. Связанная модель данных и подсказки «помогите вспомнить»

Вход «Проблемы со щитовидной железой, точный диагноз не помню» сохраняется как **описание со слов пациента**. После ответа интерфейс предлагает связанные необязательные карточки «Лекарства», «Посещения специалистов», «Обследования и документы».

Сущность	Обязательные технические свойства	Связи
Condition	id, raw_text, normalized_term?, status, onset, source, entered_by, reviewed_by, version	medication_ids, visit_ids, file_ids
Medication	id, name_raw, ingredient_verified?, dose, frequency, schedule_source, actual_use, dates	condition_ids, visit_ids, file_ids
Visit	id, specialty, approximate_date, reason, outcome, ongoing	condition_ids, medications, files
File	id, filename, mime, upload_date, study_date?, sensitivity, verified_status	conditions, visits, complaints
Symptom	id, body_system, label_raw, start, severity, frequency, baseline_status	medications, visits, files
FamilyHistory	id, relationship, reported_condition, age_onset?, source, certainty	family_tree_id
FreeNote	id, type text/audio, content, timestamp, visibility, discuss_flag	any parent entity

Статусы факта: «со слов пациента»; «не помню название»; «прикреплён документ, ещё не проверен»; «подтверждено специалистом»; «ошибка / требует уточнения». Система не должна самостоятельно изменять статус на «подтверждено».

5.1. Пример адаптивной ветки

- Вопрос «Были заболевания щитовидной железы?» → «Врач говорил о проблеме, название не помню».
- Сохранить текст и статус «не уточнено»; показать кнопку «Помогите вспомнить».
- Подсказки: «Щитовидка», «гормоны», «ТТГ», «назначали таблетки утром» — без предположений о точном диагнозе.
- Предложить: «Принимали ли лекарства по этому поводу?» → карточка препарата с названием/дозой/фото упаковки.
- Предложить: «Посещали эндокринолога?» → время и результат консультации.
- Предложить: «Есть анализы/УЗИ/заключение?» → загрузка PDF или фотографии.
- Врач видит единую связку и самостоятельно подтверждает сведения.

6. Кабинеты пациента и специалиста

6.1. Пациент: список и карточка

На главном экране первичной анкеты отображать максимум 8–10 крупных видимых карточек; остальные группируются по разделам. На карточке: иконка, название, простое описание, прогресс, статус «не начато / черновик / заполнено». Котик допустим на прогрессе, но не в медицинских предупреждениях.

При открытии подкатегории пациент видит: путь «Моё здоровье → Эндокринная система», вопросы, мини-подсказку, статус ответа, «Не помню», «Не знаю», «Пропустить сейчас», комментарий, ГС, файл, «Хочу обсудить». Все действия доступны с клавиатуры и со скринридером.

6.2. Врач: краткая сводка над полной анкетой

Сводка — это **первые 1–2 экрана**, а не сокращение первичной анкеты. Каждая карточка сводки открывает первичный ответ, документ и историю подтверждений.

Блок сводки	Что видно сразу	Действие врача
Идентификация	Возраст, дата заполнения, предпочитаемое обращение	Открыть профиль
Рост/вес/ИМТ	Число, единицы, дата и качество источника	Просмотр предыдущих измерений
Обращение	Главные жалобы, когда начались, на что влияют	Открыть причины обращения
Работа/учёба	Род занятий, график, изменения функционирования	Уточнить контекст
Заболевания	Текущие/перенесённые, отдельно со слов	Проверить источник
Лекарства/аллергии	Назначенные и реально принимаемые; БАДы	Проверить взаимодействия и схему
Другие специалисты	У кого наблюдается сейчас, когда обращался	Открыть консультации
Документы	Количество, типы, даты, непроверенные	Предпросмотр/скачивание оригинала
Психиатрический анамнез	Предыдущая помощь, препараты, госпитализации	Клиническая беседа

Блок сводки	Что видно сразу	Действие врача
Семья, социальная ситуация	Поддержка и значимые факторы	Обсудить при необходимости
Отложенные вопросы	«Обсудить лично», «Не знаю», пропущенные поля	Составить план консультации
Безопасность	Отдельный статус оценки и нужные действия	Протокол медицинского персонала

Важное разграничение: выражение «высокая тревога 7/10» — данные самооценки, но не автоматически установленный риск. ИМТ ≠ самостоятельный диагноз. Отсутствие файла не значит, что пациент не сдавал анализ.

6.3. Врач: вкладки и файловое дерево

Вкладка	Содержимое
Краткое резюме	Ключевые факты, источники, триггеры «уточнить», вопросы к приёму
Полная анкета	Древовидные разделы, все ответы, пропуски и версии
Заболевания	Системы органов, связки с лекарствами/визитами/обследованиями
Лекарства	Назначено vs фактически принимается, история отмен и реакций
Консультации	Лента посещений, рекомендации, продолжающееся наблюдение
Файлы	Фильтры по типу/дате/связанному состоянию, просмотр оригинала
Голос и комментарии	Плеер, текстовая расшифровка с пометкой статуса, «обсудить»
Родословная	Родство, сообщения о заболеваниях, степень достоверности
История изменений	Кто, когда и почему отредактировал/подтвердил сведения

7. Правила загрузки файлов и голосовых заметок

- **Пациент:** в каждой карточке видит «Добавить комментарий», «Записать голосовое», «Прикрепить файл», «Хочу обсудить с врачом». Файлы можно связать с конкретным заболеванием/визитом или сохранить без связи.
- **Превью:** список файлов с названием, типом, размером, датой обследования (если известно), датой загрузки, меткой чувствительности, статусом загрузки и возможностью удалить до отправки.
- **Врач:** исходный файл не подменяется извлечёнными данными; нет автоматического диагноза на основании текста/фото. Голос можно слушать отдельно от расшифровки, исправления расшифровки логируются.
- **Безопасность:** явное согласие, разграничение доступа, шифрование при передаче/хранении, аудит просмотров. Интимные фото не предлагать как обязательный ответ; при тяжёлых симптомах — срочный маршрут.
- **Размеры и форматы для демо:** PDF/JPG/PNG; ограничение предлагается как настраиваемое значение (например, до 10 МБ на файл). Антивирусная проверка и предупреждение о нечитабельном документе.

8. Приёмка функциональности и границы MVP

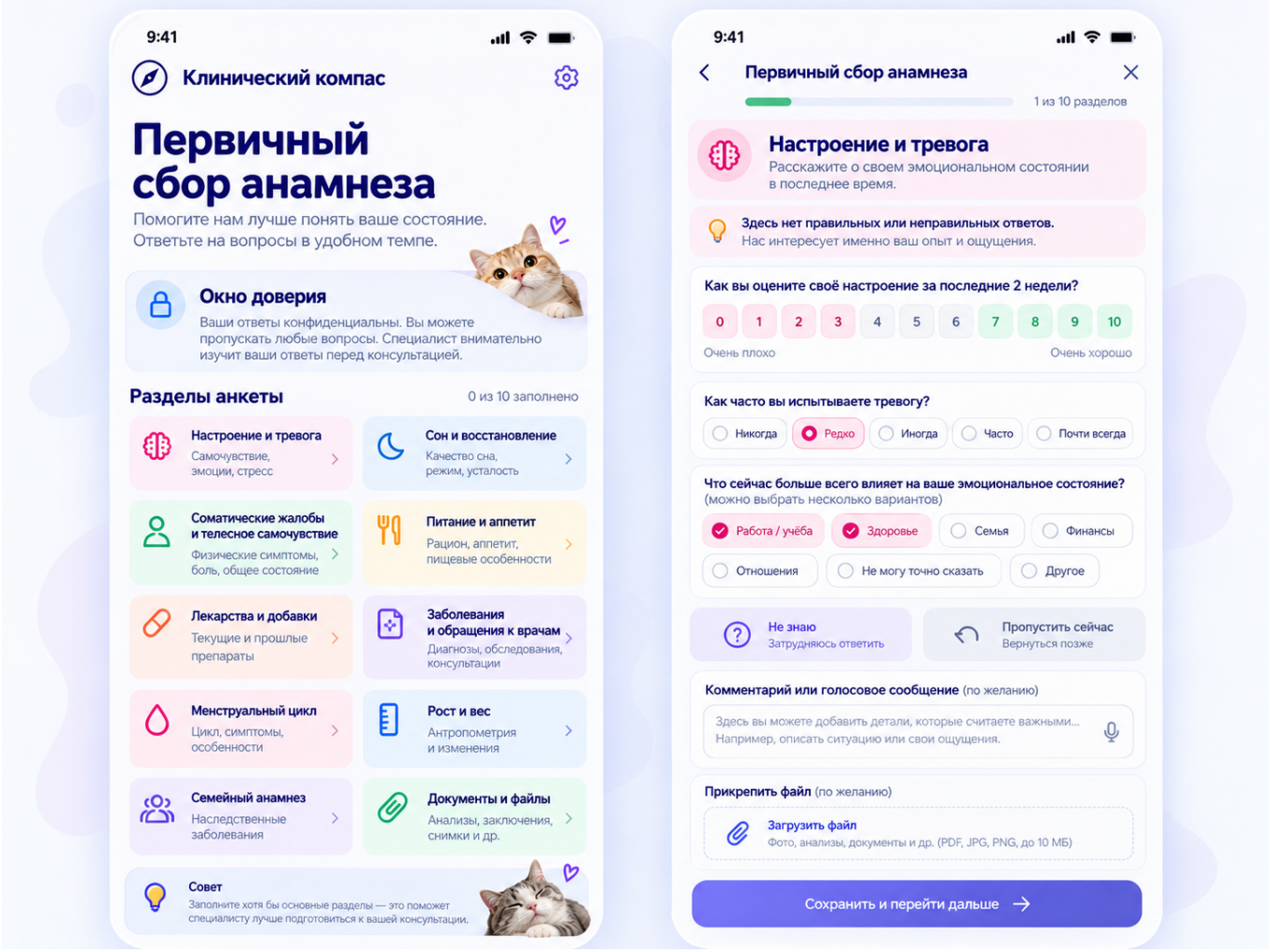
- ☐ Анкета группирует категории, скрывает ненужные вопросы, возвращает черновик без потери ответов.
- ☐ В каждом разделе есть «Не знаю», «Не помню», «Пропустить сейчас» и «Обсудить лично» там, где применимо; статусы не смешиваются.
- ☐ Любое пациентское описание заболевания сохраняется как «со слов», пока специалист не проверил.
- ☐ После указания заболевания можно добавить 0..N препаратов, визитов и файлов, сохранив связи.
- ☐ Система рассчитывает возраст и допустимый ИМТ, хранит дату, единицы и исходные значения.
- ☐ Доступны отдельные записи «назначено» и «фактически принимаю»; БАДы и безрецептурные отдельно.
- ☐ Специалист видит сводку 10–12 ключевых блоков и открывает любой факт вместе с первичным ответом.
- ☐ Врач может подтвердить, отвергнуть и запросить уточнение данных; история изменений остаётся.
- ☐ Коты только на пациентской стороне и не рядом с красными флагами; у специалиста — ни одного.
- ☐ В отчёте пропуски не превращаются в «нет заболевания», 0 баллов или «не принимал препарат».
- ☐ Вопросы о тяжёлых симптомах и суицидальности вынесены в отдельный утверждённый клинический алгоритм.

MVP-история для демонстрации: пациент описывает тревогу и усталость, вспоминает проблемы с «щитовидкой» без названия, добавляет приём лекарства, ранее посещённого эндокринолога и PDF анализа, отмечает трудности в работе. Специалист видит краткую сводку и связанные записи, уточняет сведения и настраивает индивидуальный дневник.

9. Иллюстрации экранов (макеты)

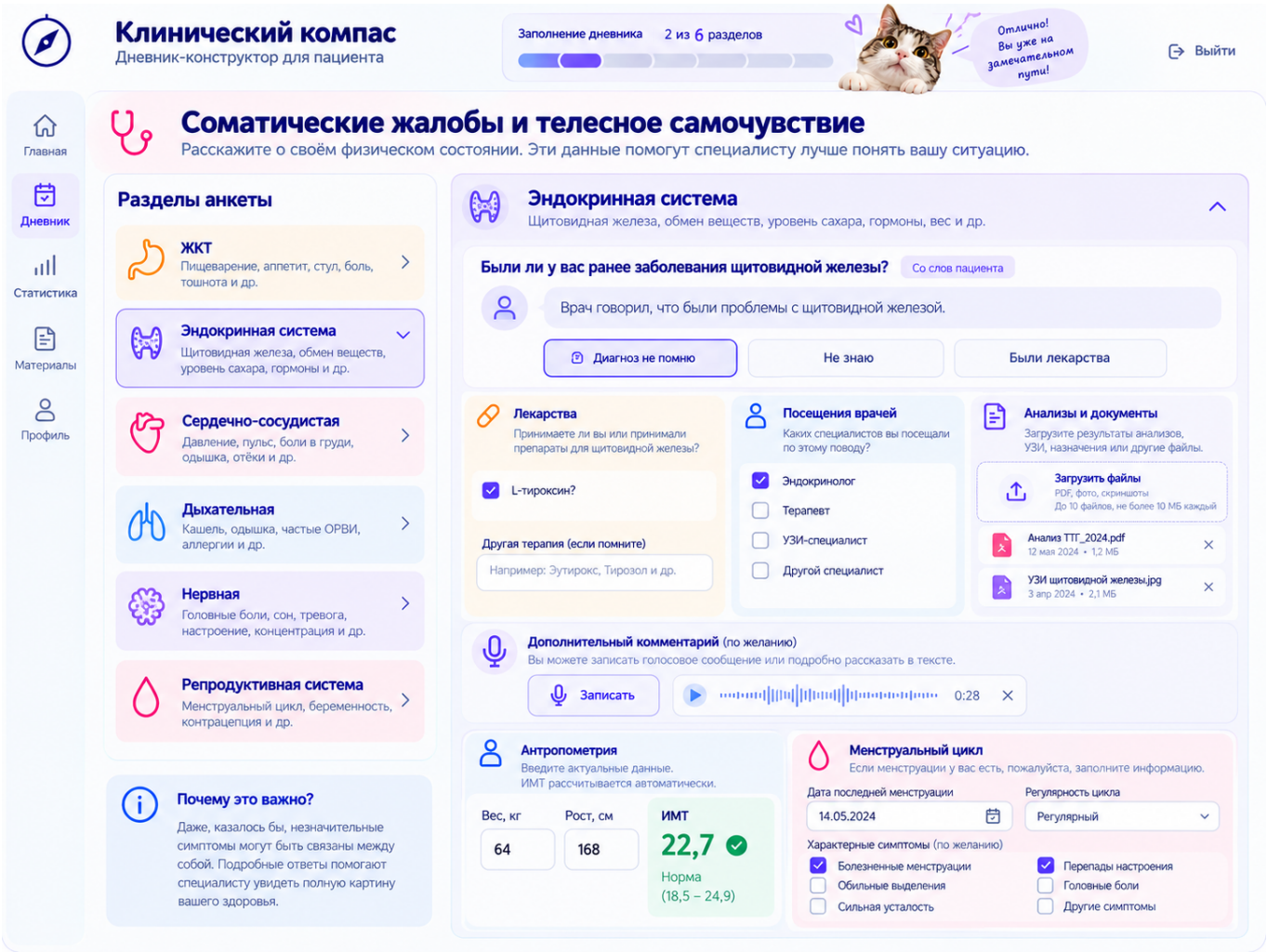
Эти визуальные материалы показывают принцип композиции и цветовую организацию. Они не заменяют текстовую спецификацию полей; демонстрационные медицинские значения и формулировки требуют проверки.

Экран 1. Первичная анкета пациента: категории, «Окно доверия», ввод комментариев и файлов



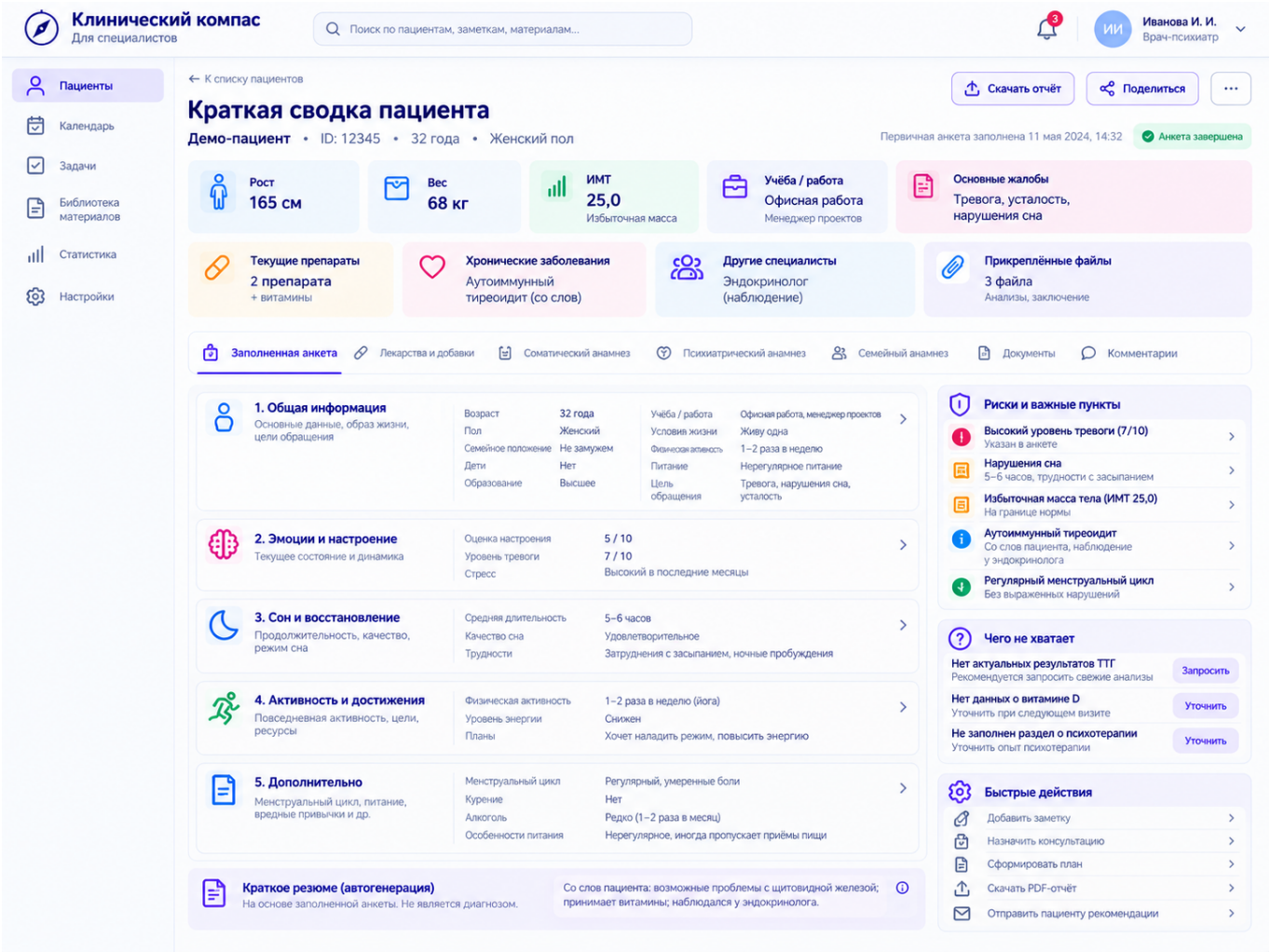
Источник: визуальный концепт по описанию проекта, не экран работающей системы. Оформление для согласования с разработчиком.

Экран 2. Соматический анамнез по системам: пример эндокринной ветки и связанные данные



Источник: визуальный концепт по описанию проекта, не экран работающей системы. Оформление для согласования с разработчиком.

Экран 3. Врачебная краткая сводка, вкладки и статус проверки фактов — без котов



Источник: визуальный концепт по описанию проекта, не экран работающей системы. Оформление для согласования с разработчиком.

Экран 4. Библиотека категорий для настройки первичной анкеты



Источник: визуальный концепт по описанию проекта, не экран работающей системы. Оформление для согласования с разработчиком.

10. Полный исходный текст функциональной концепции

В следующих разделах сохранён текст анкеты, предоставленный автором проекта. Вышеприведённая инженерная спецификация расширяет его визуальными и техническими правилами, не отменяя базовые вопросы и категории.

«Клинический компас»

Персонализированная первичная анкета пациента

Функциональная концепция для психиатра, врача-психотерапевта и психолога

Назначение: предварительный сбор медицинского, психиатрического, семейного и психосоциального анамнеза перед первой консультацией.

Главная особенность: многоуровневая анкета с тематическими категориями, понятными подсказками, автоматическими условными переходами и возможностью прикрепления документов.

Анкета заполняется пациентом самостоятельно, а информация подтверждается и дополняется специалистом во время консультации.

---

1. Общая организация анкеты

После регистрации пациент видит не длинный перечень вопросов, а крупные карточки.

Категория	Содержание
Обо мне	Личные данные, возраст, рост, масса тела
Причина обращения	Жалобы, симптомы, ожидания
Моё здоровье	Заболевания по системам органов
Мои лекарства	Текущие и прошлые препараты, аллергии
Мои обследования	Анализы, исследования, заключения
Посещения специалистов	Врачи, психологи, консультации
Моя семья	Близкие люди, отношения и поддержка
История здоровья семьи	Медицинская родословная
Учёба и работа	Занятость, график, нагрузки
Моя повседневная жизнь	Привычки, сон, физическая активность
Интересы и увлечения	Хобби, занятия, ресурсы
История жизни	Важные события, факторы стресса
Мои цели	Ожидания и предпочтения в лечении

Вопросы делятся на три типа:

Основные: собираются в первую очередь и необходимы для подготовки к консультации.

Уточняющие: появляются только после соответствующего ответа.

Дополнительные: заполняются по желанию пациента или назначению специалиста.

Оценка безопасности и действия при срочных состояниях организуются по отдельному клиническому протоколу и не зависят от того, решил ли пациент заполнять дополнительные карточки.

---

2. Категория «Обо мне»

Основные сведения

- Фамилия, имя, отчество при наличии.
- Предпочитаемое обращение.
- Дата рождения.
- Возраст — рассчитывается автоматически.
- Пол — сведения, необходимые для медицинской документации.
- Контактные данные.
- Город и часовой пояс.
- Предпочитаемый язык общения.

Антропометрические показатели

- Рост — см.
- Масса тела — кг.
- Дата последнего измерения.
- Источник: измерено самостоятельно / в медицинском учреждении / приблизительное значение.

Для взрослых индекс массы тела может рассчитываться автоматически, если известны рост и масса.

Дополнительный вопрос:

«Замечали ли вы существенные изменения массы тела за последнее время?»

Варианты:

- Да, масса увеличилась.
- Да, масса уменьшилась.
- Значительных изменений не замечал(а).
- Не знаю.
- Предпочитаю обсудить лично.

Если отмечены изменения, уточняются примерный период, величина изменения и необходимость обсуждения со специалистом.

Антропометрические параметры не должны быть обязательными для всех пользователей. Для некоторых пациентов, особенно при расстройствах пищевого поведения, отображение массы тела требует индивидуальных настроек.

---

3. Категория «Причина обращения»

Вместо одного длинного списка предлагается создать отдельный каталог жалоб.

Вопрос: «Что вас сейчас беспокоит?»

Пациент выбирает одну или несколько категорий.

3.1. Настроение и эмоции

- Часто грустно или подавленно.
- Практически ничего не радует.
- Часто хочется плакать.
- Стало трудно испытывать удовольствие.
- Появилась раздражительность.
- Часто чувствую внутреннюю пустоту.
- Бывают резкие изменения настроения.
- Чувствую безнадёжность.
- Другое.

3.2. Тревога и страх

- Постоянно о чём-то переживаю.
- Трудно контролировать беспокойство.
- Возникают приступы сильного страха.
- Боюсь, что со мной что-то случится.
- Тревожно в общественных местах.
- Боюсь оценок или осуждения других.
- Избегаю определённых ситуаций.
- Тревожат мысли о будущем.
- Другое.

3.3. Сон и энергия

- Трудно заснуть.
- Часто просыпаюсь ночью.
- Просыпаюсь слишком рано.
- Сплю много, но не чувствую отдыха.
- Постоянно хочу спать.
- Чувствую сильную усталость.
- Стало трудно выполнять привычные дела.
- Иногда сплю гораздо меньше обычного, но не чувствую усталости.
- Другое.

3.4. Мысли, внимание и память

- Трудно сосредоточиться.
- Часто отвлекаюсь.

- Стал(а) забывчивее.
- Постоянно прокручиваю одни и те же мысли.
- Есть нежелательные мысли, от которых трудно отвлечься.
- Трудно принимать решения.
- Мысли иногда кажутся слишком быстрыми.
- Другое.

3.5. Физическое самочувствие

- Сердцебиение.
- Ощущение нехватки воздуха.
- Головокружение.
- Тошнота.
- Головные боли.
- Мышечное напряжение.
- Потливость.
- Дрожь.
- Изменение аппетита.
- Боли в разных частях тела.
- Другое.

При появлении новых опасных симптомов приложение должно направлять к медицинской помощи, а не автоматически относить их к тревоге.

3.6. Отношения и общение

- Трудности в отношениях.
- Семейные конфликты.
- Чувство одиночества.
- Страх отвержения.
- Трудно общаться с людьми.
- Хочется избегать общения.
- Сложно доверять окружающим.
- Другое.

3.7. Учёба, работа и повседневная жизнь

- Сложно учиться или работать.
- Снизилась продуктивность.
- Сильная нагрузка.
- Проблемы с мотивацией.
- Трудно выполнять домашние дела.
- Сложно соблюдать распорядок дня.
- Часто испытываю стресс.
- Другое.

3.8. Поведение и привычки

- Повторяющиеся действия, которые трудно контролировать.
- Изменения пищевого поведения.
- Импульсивные поступки.
- Трудности с употреблением алкоголя или других веществ.
- Поведение, которое меня беспокоит.
- Другое.

3.9. Другие переживания

- Пережитое тяжёлое событие.
- Неприятные воспоминания, возникающие непроизвольно.
- Ощущение отстранённости от происходящего.
- Необычные ощущения или переживания.
- Другое — свободный ответ.

Уточняющие вопросы

После выбора жалобы можно уточнить:

- Когда впервые появилось это состояние?
- Как часто оно возникает?
- Насколько сильно мешает вам? (0–10)
- Замечаете ли вы ситуации, после которых становится хуже?
- Что помогает справляться?
- Хотите обсудить это со специалистом?

Не нужно показывать все шесть вопросов для каждой выбранной жалобы. Их набор определяется клинической значимостью.

Дополнительно: свободный комментарий или голосовая заметка.

---

4. Категория «Моё здоровье»

Один из основных медицинских разделов приложения.

Начальный вопрос:

«Есть ли у вас заболевания, о которых вам говорили врачи?»

Варианты:

- Да.
- Нет известных заболеваний.
- Не уверен(а).
- Не помню названия.
- Хочу обсудить лично.

Если пациент выбирает «Да» или «Не помню названия», открывается каталог систем органов.

4.1. Каталог заболеваний и понятных подсказок

Система	Примеры заболеваний	Подсказки для пациента
Сердце и сосуды	Артериальная гипертензия, аритмии, пороки сердца	«Повышенное давление», «нарушение ритма», «проблемы с сердцем»
Эндокринная	Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы	«Проблемы с сахаром», «щитовидка», «нарушения гормонов»
Желудок и кишечник	Гастрит, язвенная болезнь, ГЭРБ, воспалительные заболевания кишечника	«Изжога», «язва», «воспаление кишечника»
Печень и желчевыводящие пути	Гепатиты, заболевания печени и желчного пузыря	«Проблемы с печенью», «камни в желчном пузыре»
Дыхательная	Бронхиальная астма, ХОБЛ, другие заболевания	«Астма», «болезни бронхов», «частые проблемы с дыханием»
Нервная система	Эпилепсия, мигрень, неврологические заболевания	«Судорожные приступы», «мигрень», «неврологический диагноз»
Почки и мочевыделительная система	Хронические заболевания почек, мочекаменная болезнь	«Камни в почках», «болезни почек»
Кровь	Железодефицитная анемия, другие анемии, нарушения свёртывания	«Низкий гемоглобин», «нехватка железа», «проблемы со свёртыванием»
Иммунная и ревматологическая	Аутоиммунные заболевания, ревматоидный артрит	«Аутоиммунное заболевание», «ревматизм»
Кости и суставы	Артрит, хронические заболевания позвоночника	«Проблемы с суставами», «заболевания позвоночника»
Кожа	Псориаз, атопический дерматит	«Псориаз», «хроническая экзема»
Репродуктивная система	Гинекологические и урологические заболевания	«Нарушения цикла», «урологические заболевания»
Онкологические	Доброкачественные и злокачественные новообразования	«Опухоль», «онкологическое заболевание»
Инфекционные	Значимые перенесённые или хронические инфекции	«Тяжёлая инфекция», «последствия инфекции»
Психические расстройства	Ранее установленные психиатрические диагнозы	«Депрессия», «тревожное расстройство», «БАР», «ОКР»
Другое	Любое заболевание	Свободный ввод

Принцип работы подсказок

Если пациент вводит «проблемы с сахаром», система может показать:

«Возможно, вы имеете в виду заболевание, связанное с уровнем сахара в крови. Помните, что говорил врач?»

Варианты:

- Мне говорили о сахарном диабете.
- Мне говорили о повышенном сахаре, но диагноз не помню.
- Было другое нарушение.
- Не знаю.

Подсказка не подтверждает диагноз.

То же самое относится к словам «щитовидка», «низкий гемоглобин», «сердце», «желудок» и другим бытовым выражениям.

4.2. Карточка заболевания

После выбора заболевания открываются уточнения:

- Название заболевания, если известно.
- Кто сообщил вам об этом диагнозе?
- Когда примерно он был установлен?
- Есть ли заболевание сейчас или оно было в прошлом?
- Получаете ли лечение?
- Наблюдаетесь ли у специалиста?
- Есть ли документы, подтверждающие заболевание?
- Хотите оставить комментарий?

Статус информации:

- Подтверждено медицинским документом.
- Со слов пациента.
- Диагноз неизвестен.
- Требует уточнения специалистом.

---

5. Автоматическая связь заболевания и лекарственной терапии

После добавления заболевания появляется вопрос:

«Принимаете ли вы сейчас препараты в связи с этим заболеванием?»

- Да, регулярно.
- Да, при необходимости.
- Принимал(а) раньше.
- Нет.
- Не помню.
- Хочу обсудить лично.

Если пациент выбирает «Да», открывается карточка препарата.

Поля карточки препарата

Показатель	Формат
Название	Поиск по библиотеке препаратов или ручной ввод
Действующее вещество	При наличии подтверждённых сведений
Лекарственная форма	Таблетки, капсулы, раствор, инъекции и др.
Дозировка	Мг, мкг, мл и другие единицы
Количество за один приём	Число таблеток или другая величина
Частота	1, 2, 3 раза в день; по другой схеме; по необходимости
Время приёма	Утро, день, вечер или конкретное время
Дата начала	Дата или приблизительный период
Кто назначил	Специальность врача, при желании имя
Причина назначения	Связь с заболеванием или другая причина
Соблюдение схемы	Принимаю как назначено / бывают пропуски / принимаю иначе
Побочные эффекты	Наличие и описание
Дополнительный комментарий	Текст или голос

Если пациент не помнит препарат:

«Не помните название? Можно прикрепить фотографию упаковки, назначения или написать то, что удалось вспомнить».

Отдельно необходимо выяснять:

- Другие постоянно принимаемые препараты.
- Лекарства без рецепта.
- Витамины и БАДы.
- Растительные средства.
- Препараты, принимаемые по необходимости.
- Недавно отменённые лекарства.

Важное различие

Назначено врачом: как препарат должен приниматься по действующей схеме.

Со слов пациента: как препарат фактически принимается.

Эти сведения хранятся отдельно.

Если пациент указал препарат, но не указал заболевание, система не должна предполагать диагноз автоматически.

6. Категория «Мои анализы и обследования»

Начальный вопрос:

«Есть ли у вас результаты анализов или обследований, которые вы хотели бы показать специалисту?»

- Да.
- Нет.
- Не уверен(а).
- Есть, но сейчас не могу прикрепить.

При ответе «Да» открывается выбор категории.

6.1. Категории медицинских документов

Категория	Примеры
Общие анализы	Общий анализ крови, общий анализ мочи
Биохимические исследования	Глюкоза, креатинин, АЛТ, АСТ, липиды
Гормональные исследования	ТТГ, свободный Т4 и другие показатели
Исследования железа и витаминов	Ферритин, витамин B12, фолаты и др.
Сердечно-сосудистые обследования	ЭКГ, ЭхоКГ, мониторирование
Неврологические исследования	ЭЭГ, МРТ, КТ и другие
Гастроэнтерологические исследования	УЗИ, эндоскопические исследования
Эндокринологические обследования	Результаты консультаций и исследований
Психологические и психометрические	Результаты ранее проведённых тестов
Выписки и назначения	Заключения врачей, эпикризы
Другое	Любые медицинские документы

6.2. Карточка загруженного документа

Пациент может указать:

- Название обследования.
- Дату проведения.
- Название медицинского учреждения, если считает нужным.
- С каким заболеванием или жалобой оно связано.
- Комментарий для врача.

Форматы: PDF, фотографии, изображения и поддерживаемые медицинские документы.

Желательно предусмотреть загрузку нескольких файлов одновременно.

6.3. Что видит специалист

- Название документа.
- Дата.
- Категория.
- Состояние проверки.
- Исходный файл.
- Комментарий пациента.
- При необходимости — извлечённые показатели для проверки.

Можно дополнительно реализовать автоматическое извлечение результатов из файлов, но цифры, единицы измерения, референсные интервалы и принадлежность пациента должны проверяться до включения в медицинскую карту.

Особенность: отсутствие приложенного анализа не означает, что пациент его не сдавал.

При обнаружении результатов, требующих внимания, решение об их клинической значимости принимает специалист.

---

7. Категория «Посещения специалистов»

В начале:

«Обращались ли вы раньше к врачам или специалистам по психическому здоровью?»

- Да.
- Нет.
- Не помню.
- Предпочитаю обсудить лично.

Если «Нет» — дополнительные вопросы не появляются.

Если «Да»:

«К каким специалистам вы обращались?»

Пациенту предлагается поиск и алфавитный каталог.

Пример алфавитного списка

- Аллерголог-иммунолог.
- Гастроэнтеролог.
- Гематолог.
- Гинеколог.
- Дерматовенеролог.
- Кардиолог.
- Невролог.
- Нефролог.
- Онколог.
- Оториноларинголог.
- Офтальмолог.
- Педиатр.

- Психиатр.
- Психолог.
- Психотерапевт.
- Пульмонолог.
- Ревматолог.
- Стоматолог.
- Терапевт.
- Травматолог-ортопед.
- Уролог.
- Хирург.
- Эндокринолог.
- Другой специалист.

Психолог отображается как специалист по психологической помощи, а не автоматически как врач.

7.1. Карточка консультации

Для каждого выбранного специалиста:

Когда вы обращались?

- В течение последнего месяца.
- В течение последних шести месяцев.
- В течение последнего года.
- Более года назад.
- Не помню.

Дополнительно можно указать конкретную дату.

С какой причиной обращались?

Пациент выбирает подходящую категорию жалоб или вводит ответ самостоятельно.

Что было по результатам консультации?

- Поставлен диагноз.
- Назначено лечение.
- Назначены обследования.
- Рекомендовано наблюдение.
- Диагноз не установлен.
- Не помню.

Назначали ли вам лекарства?

Если «Да» — перейти к карточке препарата.

Назначали ли анализы или обследования?

Если «Да» — возможность указать их или прикрепить результаты.

Есть ли заключение специалиста?

Возможность загрузить документ.

Продолжаете ли вы наблюдаться?

- Да.
- Нет.
- Планирую повторное обращение.
- Не знаю.

7.2. Отдельный блок для психиатрической и психотерапевтической помощи

Если выбран психиатр, психотерапевт или психолог, уточнить:

- Причину прошлого обращения.
- Установленный диагноз, если был.
- Вид полученной помощи.
- Продолжительность лечения.
- Было ли субъективное улучшение.
- Причину прекращения лечения, если известно.
- Переносимость лекарств.
- Прошлые госпитализации.
- Что в лечении было полезным или неудобным.

Особенно полезен вопрос:

«Есть ли в прошлом лечении что-то, что вы не хотели бы повторять?»

Так специалист узнает не только медицинские факты, но и предпочтения пациента.

---

8. Категория «Моя семья»

Необходимо разделить сведения о социальной семье и медицинскую родословную.

Социальный анамнез

С кем вы живёте?

- Один/одна.
- С родителями.
- С партнёром.
- С детьми.
- С другими родственниками.
- С друзьями.
- В общежитии.
- Другое.

Как бы вы описали свои отношения с близкими?

- В целом поддерживающие.
- Бывают конфликты.
- Отношения напряжённые.
- Общаемся редко.
- Предпочитаю обсудить лично.

Есть ли человек, на которого вы можете положиться?

Да / нет / не уверен(а).

Есть ли люди, о которых вы заботитесь?

Например, дети, пожилые родственники или другие зависимые от помощи близкие.

История здоровья семьи

Отдельная интерактивная родословная.

Для каждого родственника:

- Степень родства.
- Известные заболевания.
- Приблизительный возраст появления заболевания.
- Источник информации.
- Уверенность в сведениях.
- Комментарий.

При отсутствии названия заболевания доступны такие же подсказки по системам органов, как в личном медицинском анамнезе.

Информация о суицидальном поведении родственников выясняется по отдельному деликатному алгоритму клинической оценки.

---

9. Категория «Учёба и работа»

Чем вы сейчас занимаетесь?

- Учусь.
- Работаю.
- Учусь и работаю.
- Временно не работаю.
- Другое.

При выборе «Учусь»

Дополнительные поля:

- Школа, колледж, вуз или другое.
- Направление обучения.
- Курс или год обучения.
- Формат занятий.
- Насколько интенсивна учебная нагрузка.
- Бывают ли пропуски из-за самочувствия.
- Сложно ли концентрироваться и выполнять задания.
- Что нравится в учёбе.
- Что вызывает наибольшие затруднения.

При выборе «Работаю»

Дополнительные поля:

- Сфера деятельности.

- Профессия или должность, если пациент хочет указать.
- Формат: офис, удалённая работа, смешанный.
- График: дневной, сменный, ночной.
- Приблизительная продолжительность рабочего дня.
- Уровень субъективной нагрузки.
- Есть ли профессиональные стрессоры.
- Влияет ли самочувствие на выполнение обязанностей.
- Есть ли значимые изменения работоспособности.

Точное название работодателя не нужно делать обязательным.

Общие вопросы

Насколько сейчас сложно справляться с учёбой или работой?

Шкала 0–10.

Что в этой сфере приносит вам удовлетворение?

Свободный ответ.

Что вы хотели бы изменить?

Свободный ответ.

Эти сведения особенно полезны для оценки функционирования и индивидуальных целей терапии.

---

10. Категория «Интересы и увлечения»

Этот блок я предлагаю добавить обязательно в расширенную анкету.

Психиатру и психологу важно знать не только о проблемах пациента, но и о его ресурсах.

Чем вам нравится заниматься в свободное время?

Предложить категории:

- Спорт и физическая активность.
- Музыка.
- Книги и чтение.
- Фильмы и сериалы.
- Видеоигры.
- Рисование и творчество.
- Прогулки и природа.
- Путешествия.
- Изучение языков.
- Общение с друзьями.
- Волонтёрство.
- Другое.

Изменилось ли ваше отношение к любимым занятиям за последнее время?

- Интерес сохранился.
- Стал меньше.

- Почти исчез.
- Стал сильнее.
- Трудно сказать.

Есть ли занятие, к которому вы хотели бы вернуться?

Свободный ответ.

Это может помочь специалисту обсудить ангедонию, социальное функционирование и возможные индивидуальные цели поведенческой активации.

Но снижение интереса к хобби само по себе не устанавливает диагноз.

---

11. Категория «Повседневная жизнь»

Сон

- Обычная продолжительность сна.
- Трудности с засыпанием.
- Ночные пробуждения.
- Качество отдыха.
- Изменения режима.

Питание

- Изменения аппетита.
- Регулярность питания.
- Значимые изменения пищевого поведения.

Активность

- Прогулки.
- Спорт.
- Двигательная активность.
- Время отдыха.

Привычки

- Курение и другие никотинсодержащие продукты.
- Алкоголь.
- Другие психоактивные вещества.
- Употребление кофеина.
- Другие факторы, которые пациент считает важными.

При положительных ответах могут подключаться уточняющие вопросы или валидизированные скрининги.

Повседневное функционирование

- Насколько легко выполнять бытовые задачи.
- Изменилось ли общение.
- Есть ли трудности с самообслуживанием.
- Удалось ли сохранить привычный распорядок дня.

---

12. Категория «История жизни и важные события»

Раздел должен быть деликатным и необязательным для самостоятельного подробного заполнения.

Были ли за последнее время важные изменения?

- Переезд.
- Смена работы.
- Начало или окончание обучения.
- Изменения отношений.
- Потеря близкого человека.
- Болезнь.
- Финансовые трудности.
- Семейные события.
- Другие изменения.

Хотели бы вы рассказать о событиях, которые существенно повлияли на ваше состояние?

- Да, могу написать.
- Да, хочу обсудить лично.
- Пока нет.
- Не уверен(а).

Необходимо избегать обязательного подробного описания травматического опыта в самостоятельной анкете.

---

13. Категория «Мои цели и предпочтения»

Что вы больше всего хотели бы получить от помощи специалиста?

- Лучше понять своё состояние.
- Уменьшить тревогу.
- Улучшить настроение.
- Улучшить сон.
- Вернуть силы и мотивацию.
- Улучшить отношения.
- Справляться со стрессом.
- Вернуться к привычной активности.
- Разобраться с лечением.
- Другое.

Есть ли что-то, что вас беспокоит в отношении лечения?

Например:

- Побочные эффекты препаратов.
- Изменение массы тела.
- Сонливость.
- Влияние на учёбу и работу.
- Длительность лечения.

- Конфиденциальность.
- Возможность госпитализации.
- Другое.

Какие изменения вы считали бы для себя хорошим результатом лечения?

Свободный ответ.

Далее специалист сможет преобразовать эти ответы в индивидуальные цели дневника и выбрать необходимые показатели мониторинга.

---

14. Универсальная система подсказок

Во всех больших категориях необходимо предусмотреть кнопку:

«Помогите вспомнить»

После нажатия пациент получает несколько вариантов помощи.

А. Поиск простыми словами

Например:

- «Проблемы с сахаром».
- «Щитовидка».
- «Низкий гемоглобин».
- «Нарушение ритма сердца».
- «Была язва».
- «Назначали лекарство от давления».

Система предлагает связанные понятия, но не утверждает диагноз.

Б. Поиск по системам органов

Пациент выбирает область, к которой относится проблема, и просматривает понятные названия заболеваний.

В. Вопросы-подсказки

Например:

«Помните ли вы, назначали ли вам длительное лечение по этому поводу?»

«Обращались ли вы с этой проблемой к специалисту?»

«Остались ли у вас результаты анализов или заключение врача?»

Г. Поиск по медицинским документам

Пациент прикрепляет ранее полученную выписку или назначение.

Д. Не знаю название

Пациент сохраняет описание своими словами.

В медицинской карте запись отображается как неподтверждённые сведения, требующие уточнения специалистом.

---

15. Универсальный комментарий в каждом разделе

В каждой категории нужна возможность:

- Написать текст.
- Записать короткое голосовое сообщение.
- Прикрепить файл.
- Отметить «Хочу обсудить лично».
- Выбрать «Не знаю».
- Пропустить необязательный вопрос.

Голосовые сообщения можно ограничить по продолжительности. Перед использованием автоматической расшифровки необходимы согласие, контроль доступа и возможность исправить ошибки.

Комментарии пациента отображаются отдельно от подтверждённых медицинских сведений.

---

16. Система условных переходов

Первичный ответ	Следующий вопрос	Действие
Есть хроническое заболевание	Получаете ли лечение?	Открыть карточку лекарства
Принимаю лекарство	Как называется и как принимаете?	Сохранить сведения о препарате
Не помню препарат	Есть упаковка или назначение?	Предложить загрузку фотографии
Есть результаты анализов	Хотите прикрепить их?	Открыть загрузку документов
Обращался к специалисту	К какому и когда?	Открыть каталог специальностей
Был у психиатра	Получали ли лечение?	Уточнить психиатрический анамнез
Был у эндокринолога	С какой проблемой обращались?	Связать консультацию с заболеванием
Есть заболевания в семье	У какого родственника?	Открыть родословную
Трудности с работой	Что именно изменилось?	Уточнить функционирование
Потерян интерес к хобби	Когда это произошло?	Уточнить длительность изменения
Хочу обсудить лично	Без дополнительных расспросов	Добавить тему в список консультации

Переходы должны быть гибкими: один ответ может иметь несколько связанных карточек, но пациент не обязан открывать их все сразу.

---

17. Что получает специалист

После заполнения формируется предварительная карта пациента.

Разделы врачебного отчёта:

- Личные данные.
- Основные причины обращения.
- История текущих симптомов.
- Соматический анамнез.
- Ранее установленные психиатрические диагнозы.
- Лекарственный анамнез.
- Аллергии и нежелательные реакции.
- История консультаций и лечения.
- Медицинские документы.
- Семейный анамнез.
- Социальная ситуация.
- Учёба, работа и функционирование.
- Интересы и значимые занятия.
- История жизни и стрессовые факторы.
- Цели и предпочтения.
- Статус оценки безопасности.
- Вопросы, оставленные для личного обсуждения.

Отличие подтверждённых и неподтверждённых сведений

У каждой записи должны быть:

- Источник информации.
- Дата добавления.
- Дата события или обследования.
- Статус проверки.
- Связанные документы.
- Связанные препараты и консультации.
- История изменений.

Например:

«Пациент сообщает о заболевании щитовидной железы, точный диагноз не помнит. Указал прежнее посещение эндокринолога. Препарат и дозировка требуют уточнения. Прикреплены результаты обследования от указанной даты».

Специалист получает краткий обзор и возможность открыть подробные сведения.

Важно: система не должна выдавать такой текст за уже подтверждённый врачом диагноз.

---

18. Связь с персонализированным дневником

После первичной консультации специалист использует собранные данные для индивидуальной настройки дневника.

Примеры:

Жалобы на тревогу: можно подключить субъективную интенсивность тревоги, сон, функционирование и соответствующую клиническую шкалу.

Нарушения сна: дневник продолжительности и качества сна.

Назначена лекарственная терапия: карточка приёма препаратов, переносимости и необходимых контрольных показателей.

Хроническое соматическое заболевание: соответствующие медицинские показатели по решению специалиста.

Снижение интереса к любимым занятиям: индивидуальные цели поведенческой активации.

Проблемы с учёбой: мониторинг функционирования и согласованные цели.

Исходная анкета остаётся частью медицинской истории, а дневник предназначен для динамического наблюдения.

---

19. Минимальная версия для кейс-чемпионата

Для первой демонстрационной версии достаточно реализовать следующие основные механизмы:

- Категории причин обращения.
- Каталог заболеваний с бытовыми подсказками.
- Карточку заболевания.
- Условный переход к лекарствам.
- Каталог специалистов и историю посещений.
- Загрузку результатов обследований.
- Категории учёбы, работы и увлечений.
- Семейную историю и родословную.
- Сохранение комментариев.
- Автоматическое формирование резюме для специалиста.

Лучший демонстрационный сценарий:

Пациент сообщает о тревоге и усталости, указывает заболевание щитовидной железы, добавляет препарат, прикрепляет обследование, отмечает посещение эндокринолога и сообщает о трудностях с учёбой.

Специалист получает связанную историю, проверяет сведения, оценивает состояние и формирует индивидуальный дневник.

Итог

«Клинический компас» должен не просто собирать ответы на вопросы, а помогать пациенту последовательно восстановить собственную медицинскую и жизненную историю.

Структурированные категории делают анкету понятной пациенту, условные переходы уменьшают количество ненужных вопросов, а связи между заболеваниями, препаратами, обследованиями и консультациями помогают специалисту подготовиться к приёму.

Подтверждение диагнозов, оценка результатов обследований, клиническая интерпретация симптомов и выбор лечения всегда остаются за специалистом.

Клинические источники для разработки

- APA — Practice Guidelines for the Psychiatric Evaluation of Adults.
- NICE NG222 — Depression in adults: treatment and management.

- Минздрав РФ — Депрессивный эпизод, рекуррентное депрессивное расстройство, 2024.
- NICE NG145 — Thyroid disease: assessment and management.
- NICE CG136 — Service user experience in adult mental health.
- NICE CG185 — Bipolar disorder: assessment and management.
- WHO — Medication Safety in Transitions of Care.

Сведения об источниках и проверке

Исходная функциональная концепция: текст пользователя от 21.10.2026. Дополнительные спецификации экранов, полей, модели данных, цветового оформления и приёмочных тестов составлены для разработки демоверсии. Официальные медицинские протоколы, регуляторные требования и клинические пороги должны быть проверены специалистами до внедрения.

Источники для клинической сверки, указанные в исходной концепции: APA Practice Guidelines for Psychiatric Evaluation of Adults; NICE NG222, NG145, CG136, CG185; WHO Medication Safety in Transitions of Care; соответствующие клинические рекомендации Минздрава РФ.